

MCMII-III

Inventario clínico multiaxial de Millon III

Autoras del informe interpretativo:

V. Cardenal, M. Ortiz-Tallo y P. Sánchez

Autores de la solución informática:

X. Minguijón y R. Sánchez

Informe interpretativo

PERFIL

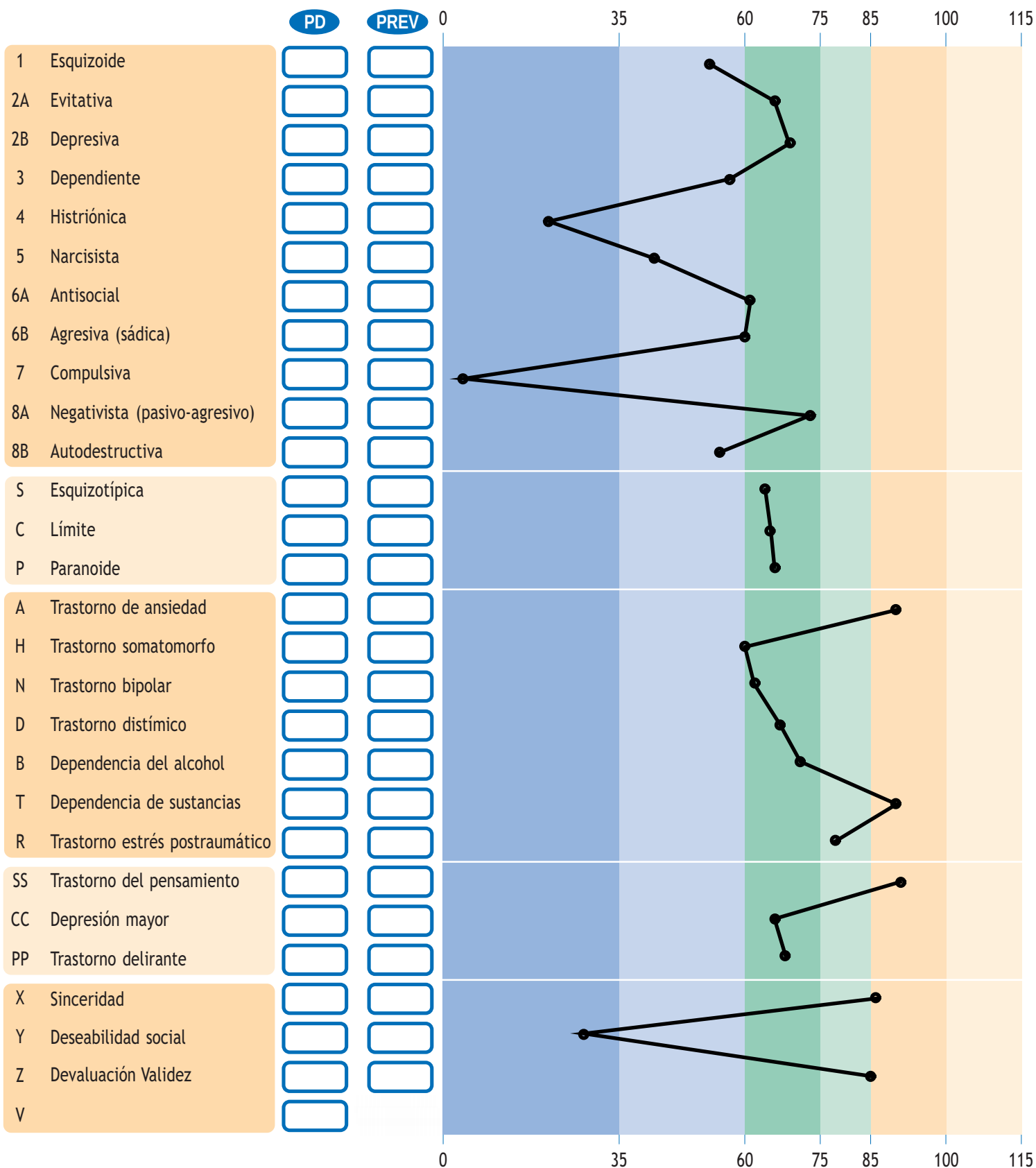


Nombre:

Edad: Sexo: Fecha de aplicación:

Baremo:

Responsable de la aplicación:



Prev: Prevalencia

Este informe es resultado de la aplicación informática del perfil obtenido a partir de los datos del Inventario Clínico Multiaxial de Millon-III (MCMI-III).

Se debe valorar e interpretar conjuntamente con todos los datos clínicos adicionales provenientes de las entrevistas y de la observación clínica.

El profesional, como resultado de sus consideraciones, podrá adaptar, añadir y cambiar los contenidos según sus propios criterios realizando así un informe definitivo. Por tanto, este informe debe considerarse de carácter orientativo para los especialistas y no se ha de mostrar a los pacientes ni a sus familiares.

A continuación encontrará seis apartados relacionados con los resultados obtenidos por Caso Ilustrativo. Estos son: 1. Actitud ante la Prueba, 2. Severidad del perfil clínico, 3. Orientaciones para el Diagnóstico, 4. Estilos y Trastornos de la personalidad, 5. Síndromes Clínicos y 6. Evaluación Multiaxial.

Nota.- Dada la relación significativa existente entre los distintos aspectos de la personalidad (relación que en ocasiones es de signo negativo), es posible que alguna frase parezca contradecir lo indicado anteriormente por otra. Ello puede ser debido a que en Caso Ilustrativo se dé esa contradicción, puesto que los adjetivos empleados aluden a unas situaciones o variables diferentes que, sin embargo, estaban relacionadas positiva o negativamente en la muestra normativa que sirvió para definir los distintos puntos de corte en dichas variables.

1. ACTITUD ANTE LA PRUEBA

En este apartado se consideran las puntuaciones obtenidas por el paciente en las escalas de Validez (V), Sinceridad (X), Deseabilidad Social (Y) y Devaluación (Z). Son indicadores que afectan a la fiabilidad y validez de este cuestionario clínico y pretenden detectar posibles irregularidades o estilos infrecuentes de respuestas.

Los resultados de este cuestionario son válidos.

El paciente se muestra revelador, abierto y expresivo en sus respuestas.

Caso Ilustrativo tiende a presentarse tal como se ve a sí mismo, sin ocultar aquello que le parece importante sobre sus sentimientos, emociones y comportamientos.

Caso Ilustrativo presenta una tendencia a valorarse negativamente, incluso peor de lo que objetivamente pudiera parecer. Conviene comprobar si está realizando una llamada de socorro o una petición de ayuda ante una situación interior de angustia.

2. SEVERIDAD DEL PERFIL CLÍNICO

En este apartado se refleja la posible existencia en el perfil clínico de puntuaciones destacadas en las escalas de patología grave de la personalidad (S -Esquizotípica-, C -Límite- y P -Paranoide-) o en las escalas severas de Síndromes clínicos (SS -Trastorno del pensamiento-, CC -Depresión mayor- y PP -Trastorno delirante-).

Caso Ilustrativo no presenta ningún estilo o Trastorno de la personalidad grave (S -Esquizotípico-, C -Límite- y P -Paranoide-) que refleje que haya tenido en su historia personal características de comportamiento y pautas de funcionamiento que dificultaran

seriamente el afrontamiento de las dificultades cotidianas.

Sin embargo, sí presenta en la actualidad alguno de los Síndromes clínicos, considerados graves o severos (SS -Trastorno del pensamiento-, CC -Depresión mayor- o PP -Trastorno delirante-). Estos síntomas podrían ser transitorios y estar indicando una crisis temporal, en la que tiene dificultades para enfrentarse a la vida diaria. Es importante estar al tanto de la evolución clínica para conocer si la existencia de un síndrome grave influye en el futuro estilo de personalidad.

Por tanto, se puede proponer que la severidad es elevada ya que presenta algún síndrome clínico severo.

3. ORIENTACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO

En este apartado se enumeran las escalas en las que Caso Ilustrativo ha obtenido puntuaciones elevadas y que indican la presencia de rasgos clínicos destacables, trastornos de la personalidad y síndromes clínicos. Lo que se ofrece al clínico es una orientación que deberá corroborar o refutar con otras fuentes provenientes de la evaluación que esté realizando a su paciente. No es un diagnóstico firme y cerrado.

Caso Ilustrativo presenta puntuaciones destacables en las siguientes escalas:

Prominencia de Trastorno de ansiedad (Escala A).

Prominencia de Trastorno por dependencia de sustancias (Escala T).

Trastorno de estrés postraumático (Escala R).

Prominencia de Trastorno del pensamiento (Escala SS).

4. ESTILOS DE PERSONALIDAD (PRESENCIA DE RASGOS CLÍNICOS) Y TRASTORNOS DE PERSONALIDAD -EJE II-

En primer lugar encontrará detalladas las escalas en las que Caso Ilustrativo ha obtenido una puntuación que indica la presencia de rasgos clínicos de personalidad. En segundo lugar, hallará una descripción-prototipo de las características clínicas propias de las escalas con puntuaciones que indican un Trastorno de la personalidad.

Por último, en el caso de la coexistencia de dos o más Trastornos de la personalidad se expondrá un resumen que contemple la asociación de los rasgos patológicos de los mismos, en el caso de que presenten alta o moderada comorbilidad.

Caso Ilustrativo no presenta puntuaciones de corte para considerar la presencia de algún Rasgo clínico o Trastorno de la personalidad.

5. SÍNDROMES CLÍNICOS -EJE I-

Los Síndromes clínicos son trastornos mentales y del comportamiento que pueden ser relativamente transitorios, aumentando o disminuyendo con el tiempo en función de situaciones estresantes.

En este apartado, por tanto, aparecerá la descripción de los Síndromes clínicos que padece el paciente a partir de la evaluación de las diferentes escalas. El profesional deberá tener en cuenta que los Síndromes con una puntuación de prevalencia (PREV) superior a 84 indican Prominencia de ese síndrome clínico, lo que supone la presencia de síntomas clínicos serios y prolongados que pueden alterar acusadamente todas las funciones psicosociales. Se necesitará, por tanto, una cuidadosa evaluación profesional y la programación de una intervención psicológica lo más completa posible.

Posteriormente, en el caso de la coexistencia de varias escalas afectadas, aparecerá un resumen que considere la combinación de los Síndromes.

TRASTORNO DE ANSIEDAD (Escala A)

El paciente muestra un Trastorno de ansiedad. Caso Ilustrativo puede estar sintiendo que los problemas diarios le desbordan y es posible que no se sienta con fuerzas para afrontarlos; consecuentemente tenderá a alejarse de situaciones que le provoquen niveles de ansiedad medios o elevados. Cuando no consiga evitarlas, sentirá un malestar o ansiedad significativa que pueden reflejarse en sensaciones de tensión, inquietud desasosiego e inseguridad. A veces, la persona presenta quejas físicas referidas a distintas partes del cuerpo como palpitaciones, cefaleas, dolores en las articulaciones y otro tipo de molestias inespecíficas. Podría también tener dificultades para dormir.

Es frecuente, por tanto, que Caso Ilustrativo tenga imposibilidad de relajarse y que reaccione de forma exagerada ante estímulos de baja intensidad, mostrando excesiva sudoración en las manos y una opresión en el pecho y el estómago. Suele exhibir una hipervigilancia generalizada de su entorno y tiende a interpretar los conflictos de la vida diaria de forma distorsionada y con gran susceptibilidad.

Es conveniente que el profesional explore más fondo en la entrevista si se trata de un estado de ansiedad generalizada o de una fobia y, de ser esto último, si la fobia es de tipo simple o social.

TRASTORNO POR DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS (Escala T)

La persona con alta puntuación en Dependencia de las drogas es muy probable que presente una historia continuada o reciente de abuso de drogas. Es frecuente que Caso Ilustrativo no sea capaz de controlar sus emociones e impulsos y, como consecuencia, tienda a transgredir ciertos límites y normas sociales. Esta falta de represión, a menudo, propicia que se desencadenen conflictos en su vida diaria ya que le cuesta prever las consecuencias de su conducta poco reflexiva e irresponsable, en muchas ocasiones.

El valor fundamental de esta escala es la posibilidad que tiene el profesional de acceder de manera discreta a estos aspectos de la vida del paciente relacionados con el abuso de drogas, ya que pueden ser difíciles de reconocer abiertamente en una entrevista cara a cara por la sensación de vergüenza que le causa el hecho en sí mismo, con la consecuente ocultación de esta información.

La dependencia de sustancias va relacionada con irresponsabilidades, problemas legales y comportamientos antisociales y desviados de la norma en la vida del paciente.

El profesional ha de considerar la importancia de valorar detenidamente los comportamientos de abuso de drogas por su directa repercusión en todas las áreas vitales: familiares, laborales y sociales.

TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (Escala R)

Caso Ilustrativo ha experimentado un suceso traumático que implicaba una fuerte amenaza y que se encontraba fuera del contexto y experiencia habituales de su vida. Como consecuencia, presenta pensamientos intrusivos y recurrentes sobre ese hecho que le llevan a padecer un importante malestar, intenso miedo y fuertes sentimientos de indefensión.

El acontecimiento estresante puede ser reexperimentado de diversas maneras, de forma que las imágenes y emociones asociadas con el trauma aparecen en la persona en forma de

recuerdos muy reales y de pesadillas durante el sueño, reactivando así los sentimientos de miedo y angustia generados por la situación original.

Los síntomas pueden determinar dificultades en la concentración y trastornos del sueño, así como también reacciones de ansiedad ante lugares o circunstancias que le recuerden al trauma. En esos momentos, esta persona tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo y lo revive con la misma intensidad.

TRASTORNO DEL PENSAMIENTO (Escala SS)

Esta escala es una de las tres consideradas graves en el MCMI-III por lo que, como ya se ha señalado en el apartado de Severidad, el clínico debe estar alerta ante el conjunto de síntomas especialmente desadaptativos que pueden aparecer en el paciente.

Caso Ilustrativo muestra un pensamiento incongruente, extraño, fragmentado y sin coherencia, apareciendo ante los demás como disperso, desorientado y despersonalizado. En ocasiones, puede mostrar emociones y sentimientos poco adecuados al contexto, alucinaciones dispersas y delirios no sistemáticos.

Son habituales las ideas de autorreferencia. Los sentimientos son confusos y carentes de expresividad y, a menudo, se puede sentir incomprendido y aislado de los demás. Es importante destacar la aparición, con frecuencia, de comportamientos inhibidos y aislados que otorgan a Caso Ilustrativo un aire de misterio y secretismo.

Si muestra alucinaciones, ideas delirantes, lenguaje desorganizado y problemas de comportamiento, se debe considerar la evaluación conjunta con la escala de Trastorno delirante. Constituiría, en este caso, una sintomatología psicótica que podría indicar un episodio psicótico breve, pero también una esquizofrenia.

Trastorno de ansiedad y Dependencia de sustancias

El diagnóstico de Dependencia de sustancias y Trastorno de ansiedad indica la existencia de un malestar psíquico y físico frecuente que impulsa a este paciente a consumir algún tipo de droga. Esta dependencia de sustancias provoca un deterioro en todos los niveles de la vida del individuo, personal, familiar y social.

Habitualmente, le puede costar mucho reprimir sus impulsos para mantenerlos dentro de unos límites y suele ser incapaz de manejar las consecuencias personales de este comportamiento. Conviene valorar el tipo de sustancias que consume y la repercusión en todas las facetas de su vida.

El paciente con ansiedad, a menudo, siente que las preocupaciones le desbordan y puede que no se sienta capaz de afrontarlas. Tenderá, por tanto, a aumentar el consumo de sustancias para evitar la angustia que las situaciones tensas le provocan. Así mismo la necesidad del tóxico le provocará estados de ansiedad intensos.

Trastorno de ansiedad y Trastorno de estrés postraumático

La aparición del Trastorno de ansiedad junto con el Trastorno de estrés postraumático es lógica. El suceso se está reviviendo a través de un intenso malestar en forma de tensión, inquietud, dificultades en el sueño y problemas para concentrarse. El temor y la desesperanza llevan a este paciente a evitar de forma constante los estímulos y situaciones que tenga asociados al acontecimiento traumático. La ansiedad forma parte, por tanto, del mismo cuadro postraumático.

Conviene que el clínico revise a partir del manual de la prueba las respuestas que ha dado el

paciente en el área de Abuso en la infancia de la sección Respuestas llamativas, para comprobar si hay alguna situación de este tipo que pudiera estar relacionada con el síndrome.

Trastorno de ansiedad y Trastorno del pensamiento

Es frecuente que a Caso Ilustrativo, al presentar una alteración del pensamiento de gravedad, le acompañe una sintomatología ansiosa.

Su confusión y desorientación, el afecto inapropiado, e incluso la posibilidad de alguna alucinación o delirio le conducen a situaciones de intensa inquietud y desazón que se definen como ansiedad.

Es probable que este malestar se refleje en temor, ya que los pensamientos y la tendencia a aislarse de los demás propician que tienda a interpretar la realidad de forma distorsionada y amenazante.

Conviene que el clínico revise a partir del manual de la prueba las respuestas que ha dado el paciente en el área de Aislamiento social de la sección Respuestas llamativas, ya que hallará información relativa a conductas propias sobre el estilo de relacionarse de esta persona.

Dependencia de sustancias y Trastorno de estrés postraumático

La aparición conjunta del estrés postraumático y el abuso de sustancias puede sugerir que ha habido un acontecimiento traumático en la vida de Caso Ilustrativo que no ha podido afrontar de forma adecuada y lo está haciendo, consiguientemente, por medio de la ingesta de sustancias, tratando de evadirse así de los pensamientos recurrentes relacionados con el trauma original.

También el abuso de drogas puede ocasionar problemas y situaciones de toda índole y alguna de ellas haber sido de gran impacto emocional y, por tanto, haber desencadenado el estrés postraumático.

Dependencia de sustancias y Trastorno del pensamiento

El diagnóstico dual de Trastorno del pensamiento y la Dependencia de sustancias determina un estado de confusión y de pensamiento desorganizado que podría ser consecuencia de alguna droga.

Algunas sustancias pueden producir estados de confusión y alteraciones de la percepción. La obnubilación de la conciencia y del pensamiento puede formar parte también del síndrome de abstinencia tras haber suprimido o reducido sustancialmente la ingestión del tóxico.

Trastorno de estrés postraumático y Trastorno del pensamiento

La sintomatología asociada al Trastorno del pensamiento puede ser totalmente independiente del posible hecho traumático vivido.

Sin embargo, los sentimientos embotados, las conductas retraídas y la sensación de ser incomprendido y aislado por los demás que acompañan al Trastorno del pensamiento podrían también formar parte de las consecuencias del estrés postraumático.

6. EVALUACIÓN MULTIAXIAL: RELACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD (EJE II) CON LOS SÍNDROMES CLÍNICOS (EJE I)

Se ofrece en este apartado la interpretación de los significados de los síntomas en el contexto

del estilo o del Trastorno de la personalidad del paciente. Se pretende, por tanto, dotar de sentido al síndrome clínico mediante la comprensión global de la persona. Igualmente, el síndrome clínico que sufre el paciente afectará probablemente también a su estilo individual de percibir, pensar, sentir y comportarse. El tratamiento, por tanto, deberá ir encaminado tanto a la modificación de síntomas clínicamente significativos como de los rasgos básicos y el estilo de afrontamiento de Caso Ilustrativo que estén propiciando la patología o impidiendo la puesta en marcha de estrategias adaptativas.

El paciente no presenta trastornos de la personalidad por lo que este apartado no se considera.